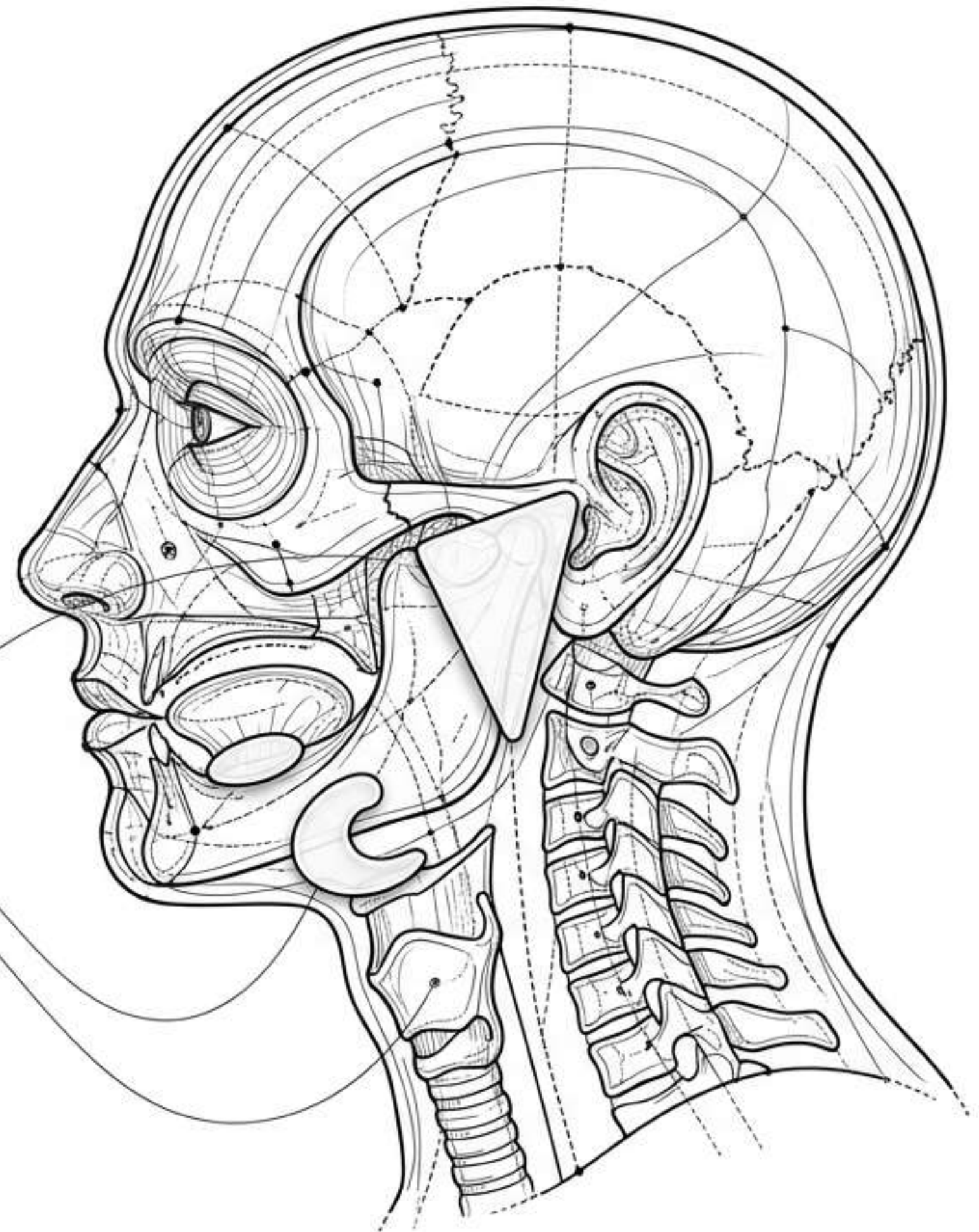


ANATOMIE DES GLANDES SALIVAIRES

Synthèse Structurale, Topographique
et Clinique (Exam Blueprint Edition)

Table des Matières :

- I. Introduction & Physiologie Exocrine
- II. Glandes Salivaires Accessoires
- III. Glandes Salivaires Principales
(Parotide, Submandibulaire, Sublinguale)
- IV. Matrice Comparative
- V. Analyse des Modèles d'Examen
(Exam Pattern Analysis)
- VI. Carte Mentale Exhaustive



Introduction : Les glandes salivaires sont des glandes exocrines annexées à la cavité orale.

Production : environ 1.5L de la salive par jour

Aide à la mastication, à la digestion et à la protection de la muqueuse orale.

Les Glandes Salivaires Accessoires (Mineures)

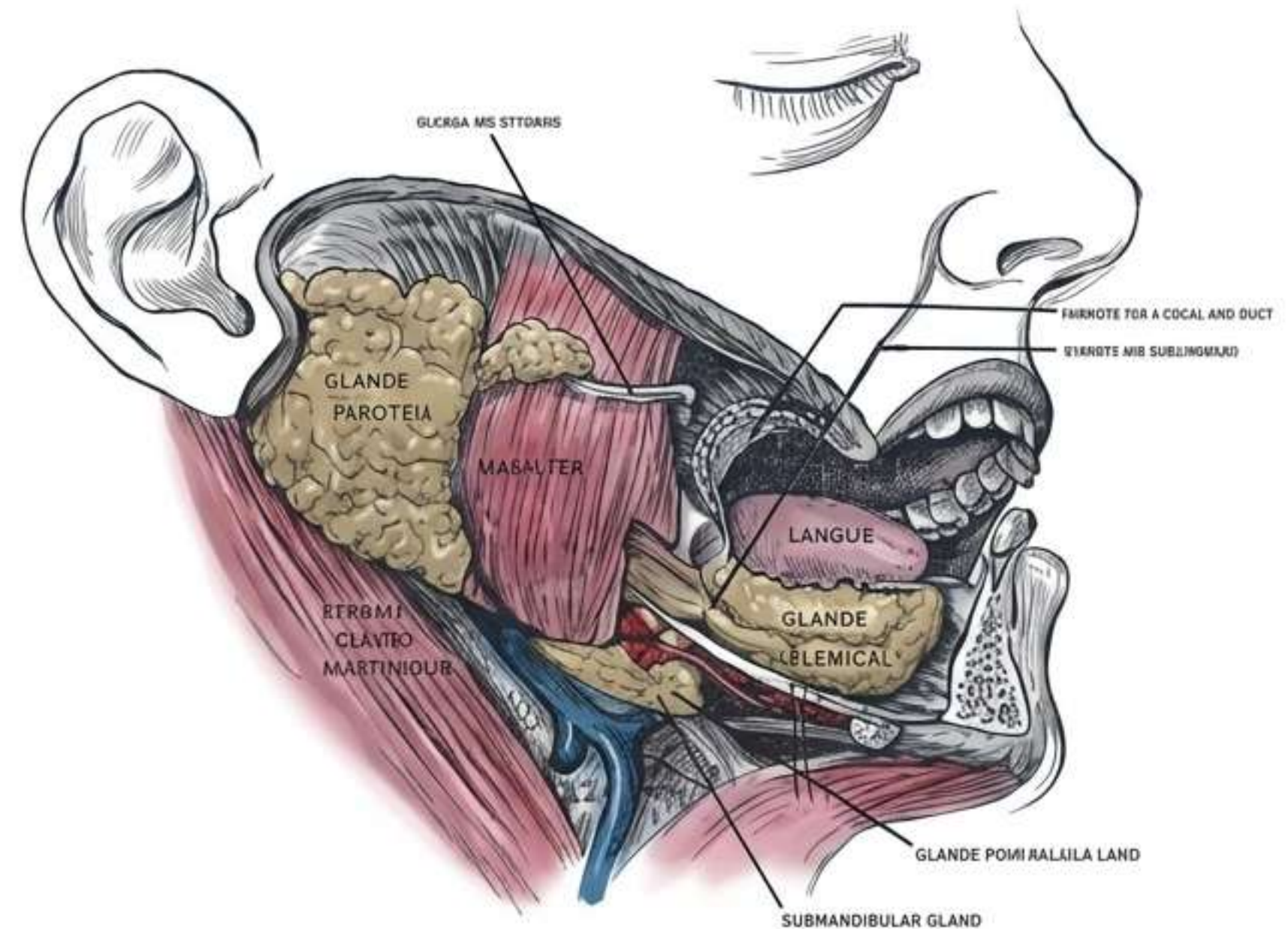


Fonction : Elles réalisent une sécrétion permanente de la salive

Structure : Dispersées dans la muqueuse de la cavité orale sous forme de petits amas glandulaires très nombreux, avec des canaux excréteurs courts.

Classification (4 types exclusifs) : Les glandes labiales, les glandes linguales, les glandes jugales et les glandes palatines.

Principales Glandes Salivaires



Définition des Glandes Principales (Majeures)

Anatomie

Amas glandulaires bien individualisés en dehors de la muqueuse orale, entourés d'une capsule conjonctive.

Drainage

S'ouvrent dans la cavité orale par un conduit excréteur propre.

Physiologie

Leurs sécrétions est discontinue et déclenchée par un stimulus soit olfactif, soit visuel, soit gustatif, ou psychique.

Classification Topographique (3 Paires autour de la mandibule) :

1. Glandes parotides
2. Glandes submandibulaires
3. Glandes sublinguales

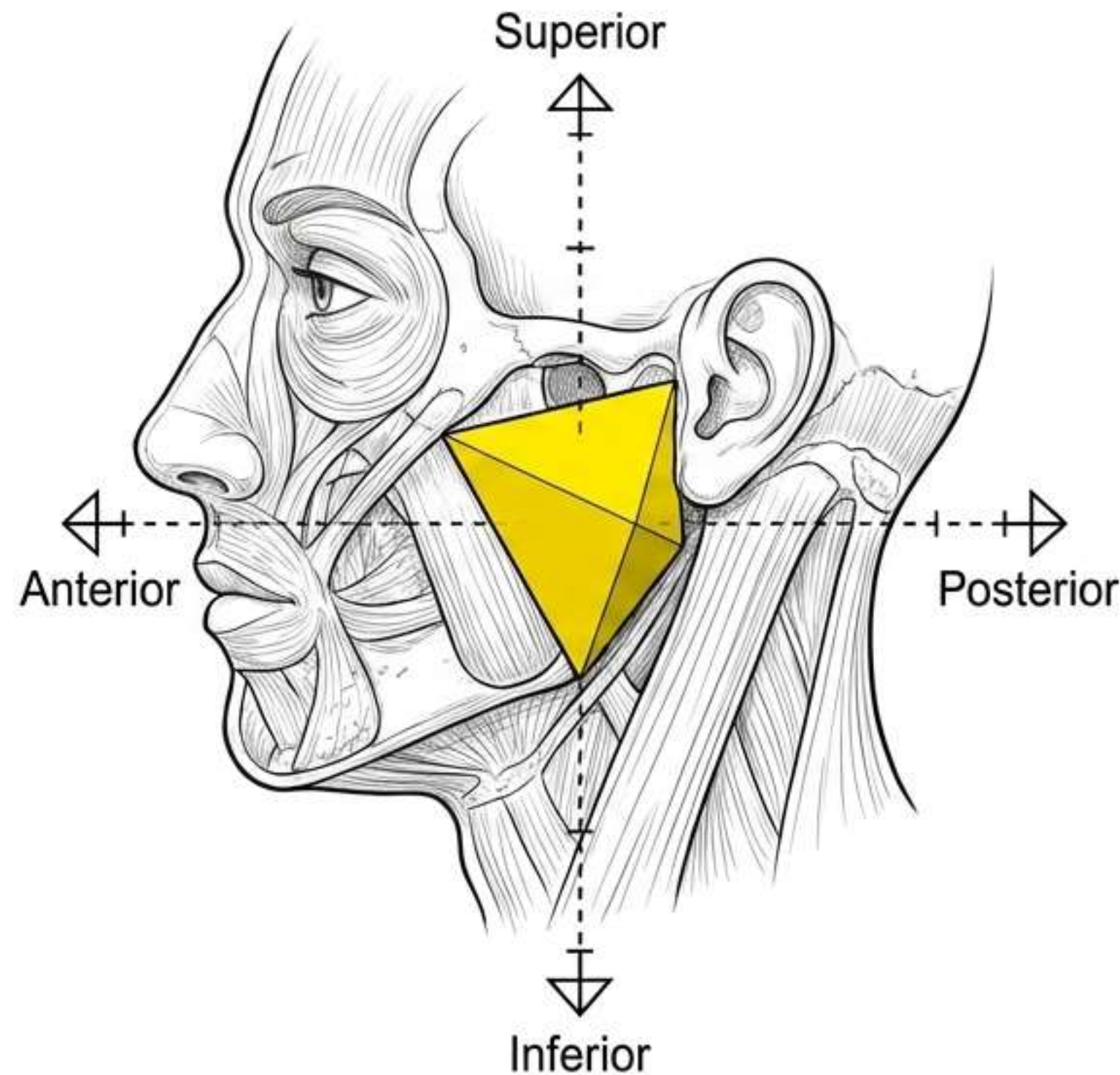
Glande Parotide : Identité Morphologique

Hierarchie : C'est la plus volumineuse et la plus postérieure des glandes salivaires.

Poids : Pèse environ 25g

Forme de prisme triangulaire, axe oblique en bas/avant, recouverte par capsule mince.

Deux prolongements : massétérin antéro-latéral et pharyngien médial.



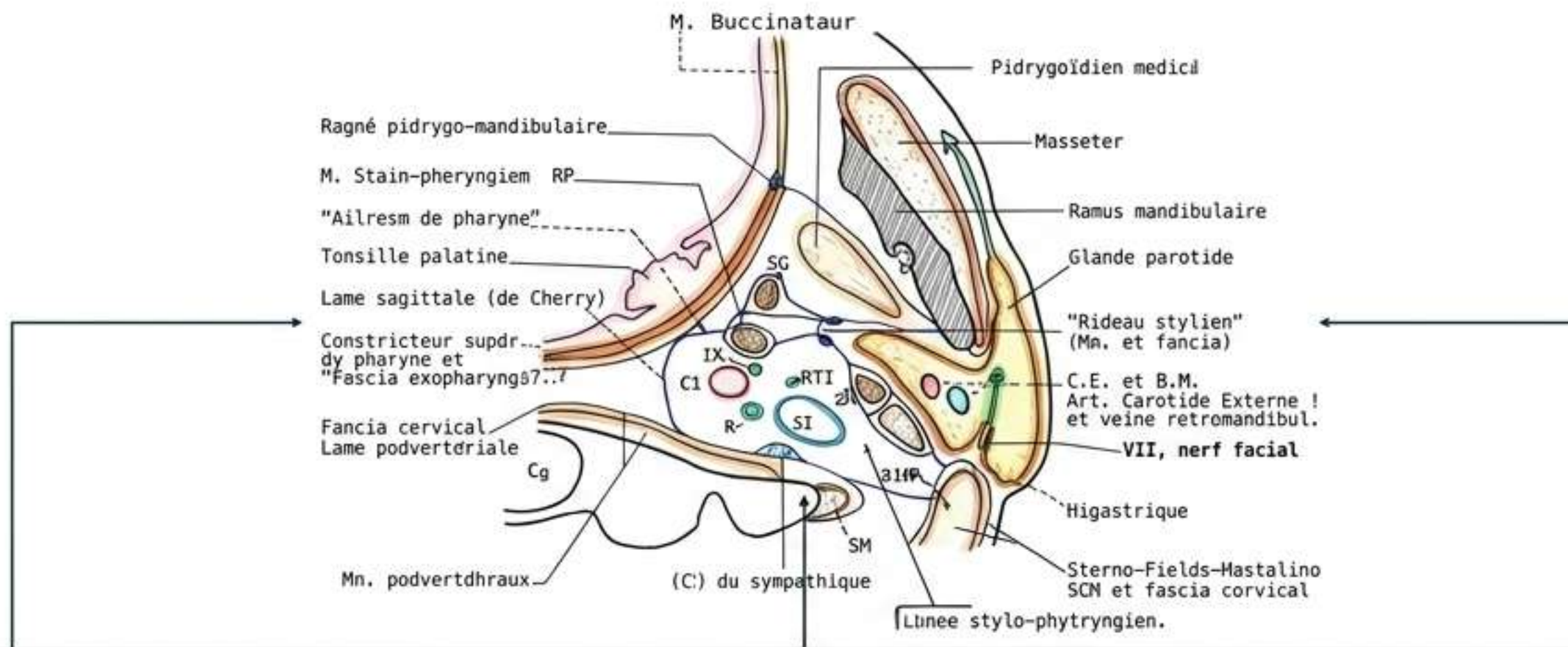
Situation Anatomique (Limites Superficielles) :

En avant : Branche montante de la mandibule.

En arrière : Apophyse mastoïde + muscles sterno-cléido-mastoïdiens (SCM).

En haut : Partie postérieure de l'arcade zygomatique + conduit auditif externe.

En bas : Ligne partant de la mastoïde à l'angle de la mandibule.



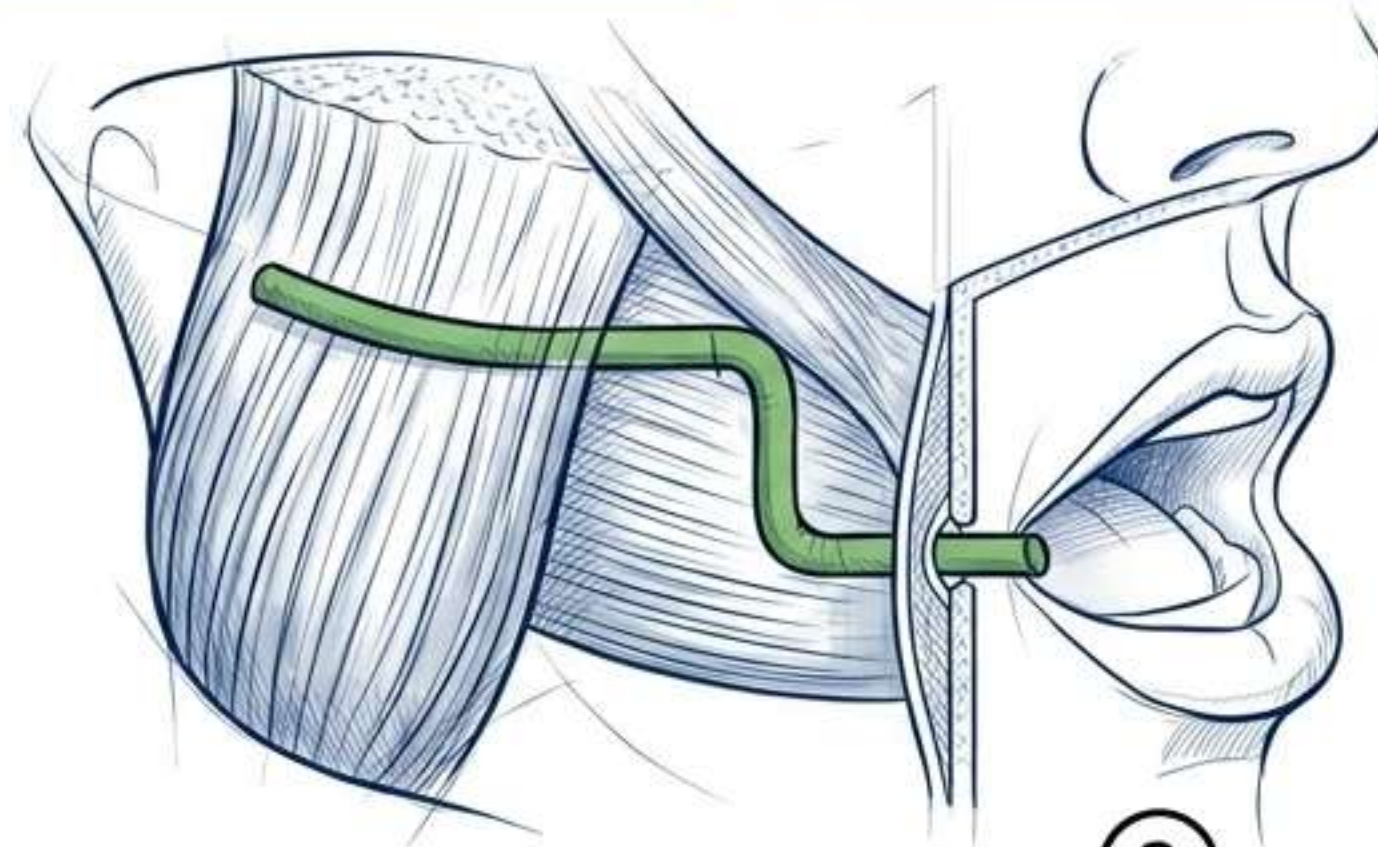
La Loge Parotidienne (Excavation Structurale)

Paroi Antérieure	Paroi Latérale	Paroi Postérieure (Diaphragme Stylien)
Bord postérieur de la branche de la mandibule avec le bord postérieur du muscle masséter en dehors et le bord postérieur du muscle ptérygoïdien médial en dedans.	Voie d'abord chirurgicale de la glande. De dehors en dedans : Peau + platysma → Tissu sous-cutané → Lamé superficielle de l'aponévrose cervicale (fascia cervical superficiel) entre bord ant. du SCM et masséter.	Cloison fibro-musculaire qui sépare la loge parotidienne en avant de la région rétro-stylien en arrière. De dehors en dedans : Ventre post. du digastrique → Muscle stylo-hyoïdien → Ligaments stylo-hyoïdien/stylo-mandibulaire → Muscles stylo-glosse et stylo-pharyngien.

Conduit Excréteur : Le Canal de Sténon (Conduit Parotidien)

C'est le conduit excréteur propre et exclusif de la glande parotide.

Mesure 4 cm de long.



①

Initialement horizontal, posé contre la face latérale du muscle masséter

(Piège: il ne perfore JAMAIS le masséter)

②

Deviens vertical jusqu'au muscle buccinateur qu'il perfore.

③

De nouveau horizontal sous la muqueuse buccale.

④

S'ouvre dans le vestibule (cavité orale) en regard du collet de la 2^{ème} molaire supérieure.

Rapports Extrinsèques de la Parotide (Pièges d'Examen)

Ces rapports se font par l'intermédiaire de la loge parotidienne.

En Arrière : L'Espace Rétro-Stylien (Sous-Parotidien Postérieur)

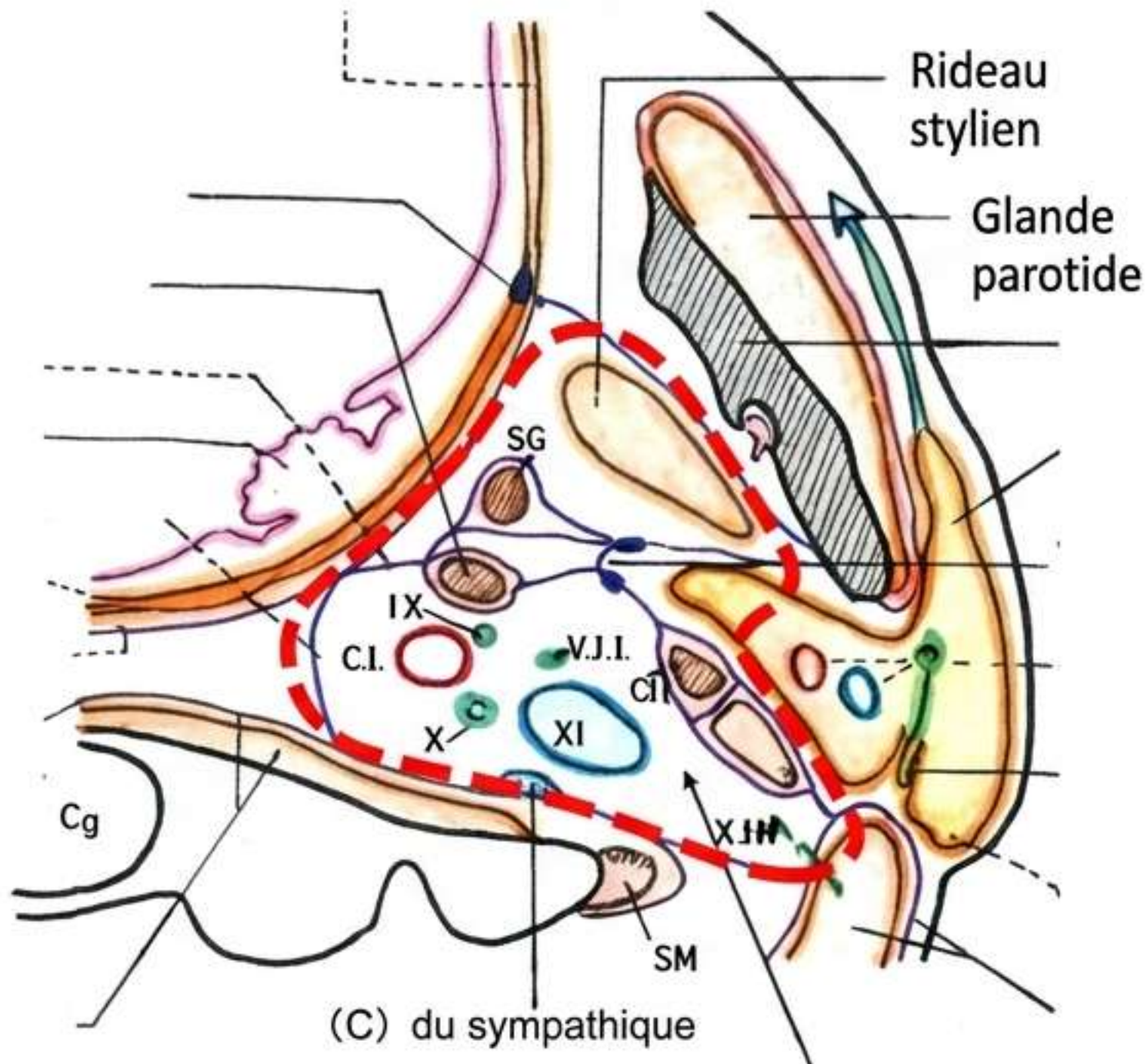
- **Vaisseaux Majeurs** : L'artère carotide interne et la veine jugulaire interne.
(Attention: Toujours **EXTRINSÈQUES**).
- **Nerfs Crâniens** : Nerf glossopharyngien (IX), nerf pneumogastrique (X), nerf spinal (XI), grand hypoglosse (XII).
- **Système Végétatif** : La chaîne sympathique.

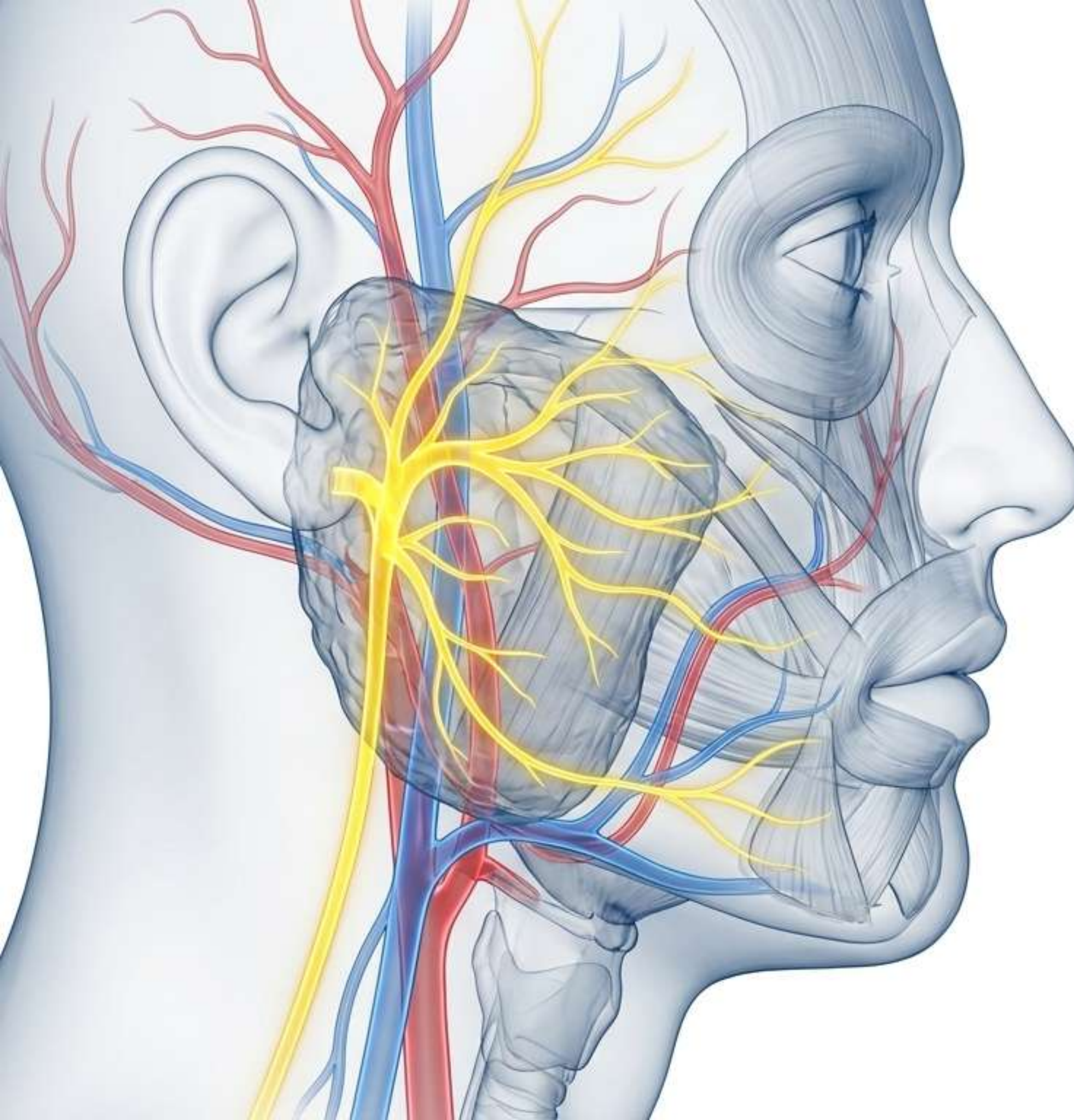
Médialement : l'Espace Para-Tonsillaire

- **Contenu** : Le muscle stylo-glosse, les artères palatines et pharyngiennes ascendantes.

Latéralement : Espace Superficiel

- La parotide est palpable sous la lame superficielle du fascia cervicale et la peau.





Rapports Intrinsèques (Traversant la Glande)

Innervation Intra-Parotidienne :

Nerf facial.

Corrélation Clinique : Peut être comprimé par une tumeur parotidienne (paralysie faciale périphérique) ou lésé en chirurgie.

Nerf auriculo-temporal (branche du nerf mandibulaire V3).

Vascularisation Intra-Parotidienne :

Artère carotide externe.

Veine jugulaire externe.

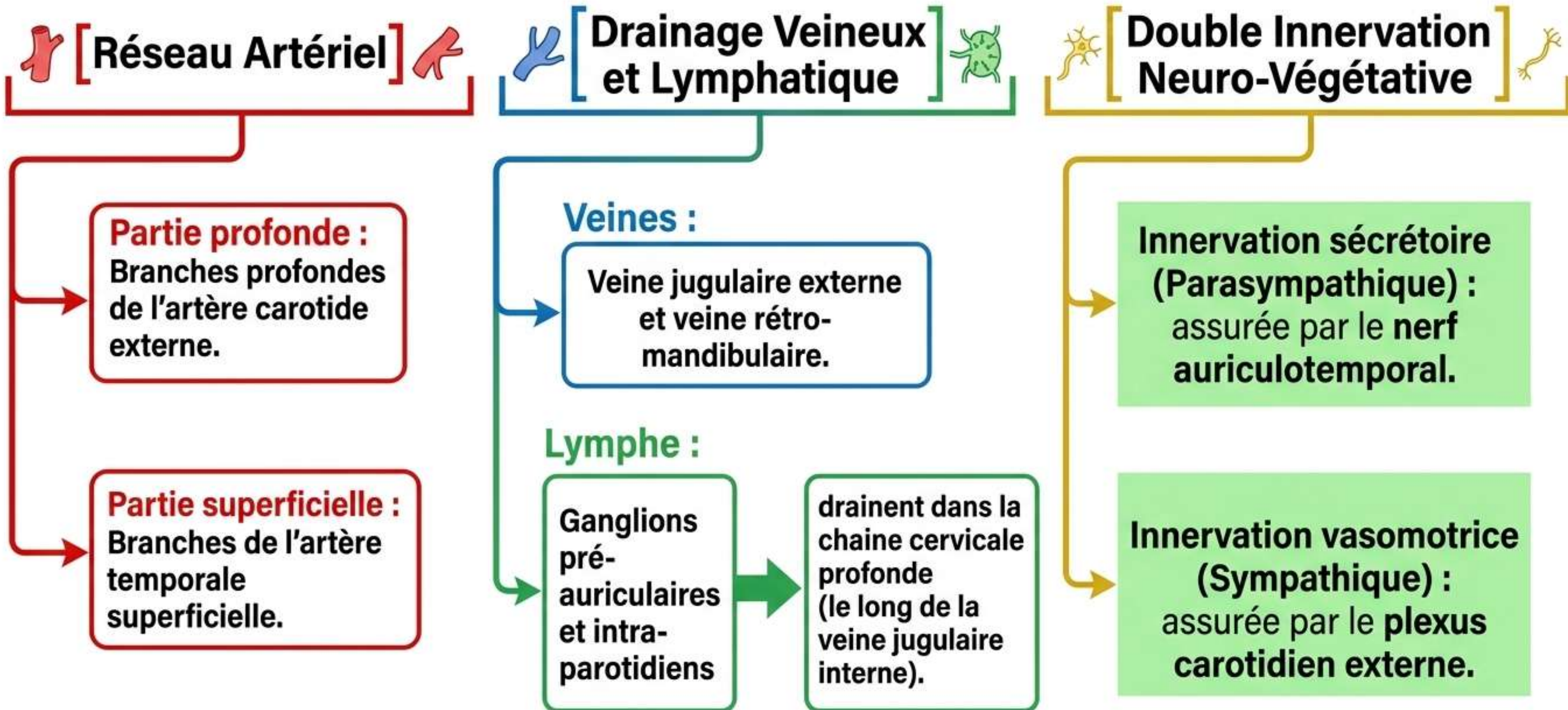
Veine rétro-mandibulaire (veine faciale postérieure).

Veine carotide externe.

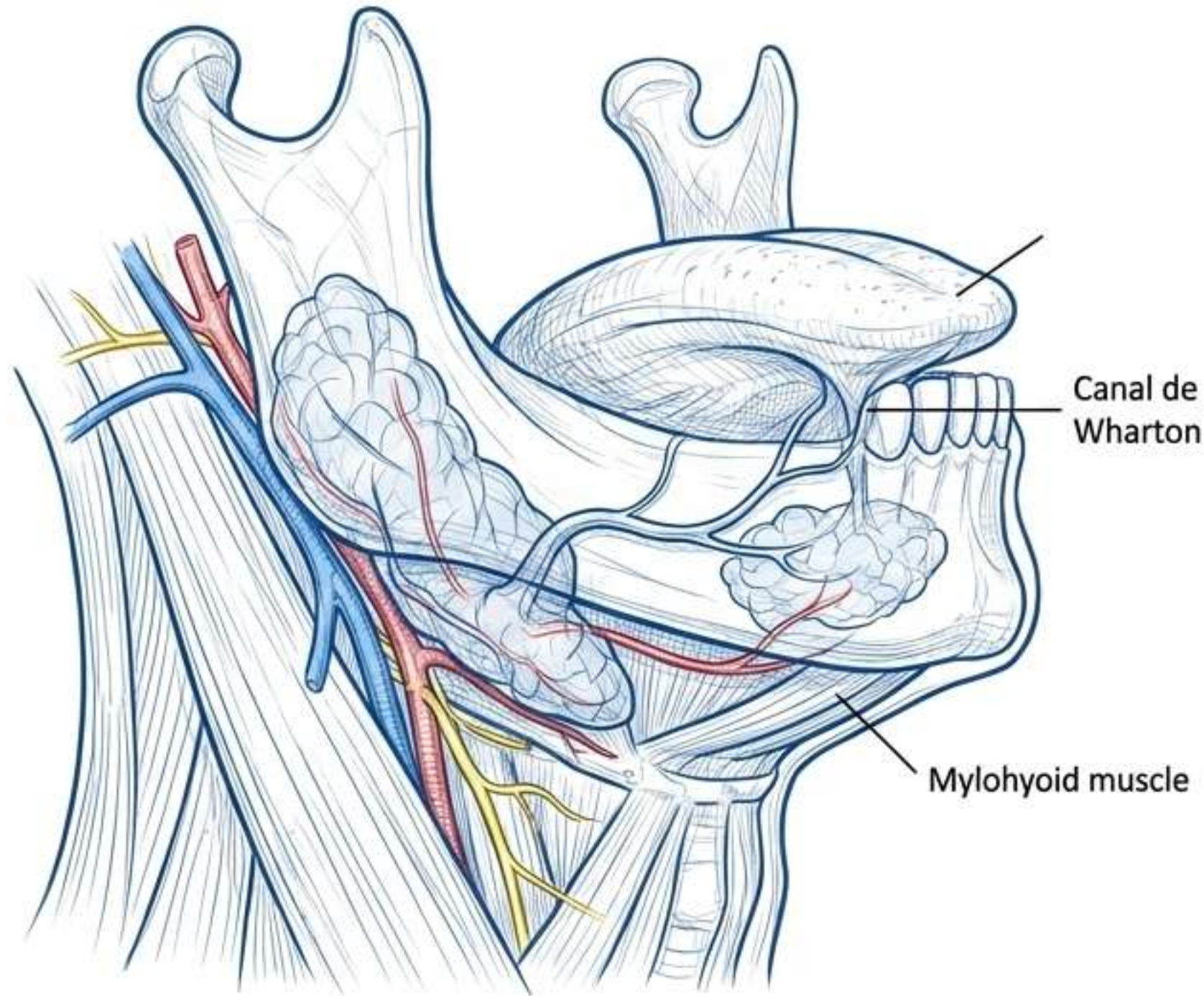
Système Lymphatique :

Lymphonœuds intra-parotidiens.

Vascularisation et Innervation de la Parotide



Glande Submandibulaire (Sous-Maxillaire)



Morphologie et Situation :

Taille : Plus petite que la parotide, pesant environ 7g.

Située dans la loge submandibulaire, dans l'angle formé par la mandibule et les muscles sus-hyoïdiens.

En forme de crochet avec un prolongement antérieur qui s'insinue en dedans du muscle mylo-hyoïdien.

Le Canal de Wharton (Conduit Excréteur) :

Naît du prolongement antérieur.

Terminaison : Au niveau de la **caroncule salivaire**, située à la base du frein de la langue (débouche par l'ostium ombilical).

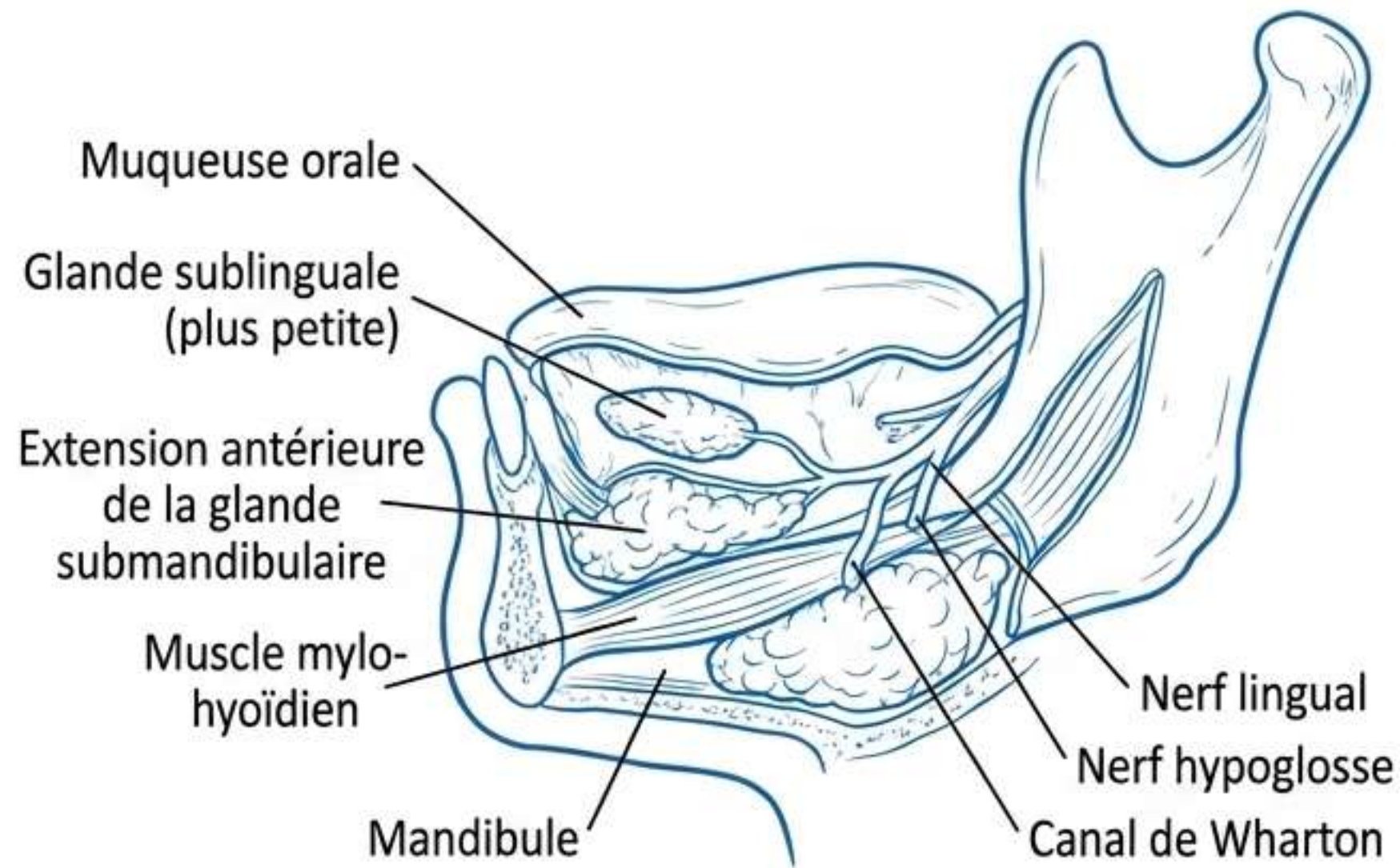
Rapports Vasculo-Nerveux :

Veine faciale et **Artère faciale**.

Ganglions pré-glandulaires (prés/rétro vasculaires) et rétroglandulaire.

Nerf lingual et **Nerf grand hypoglosse**.

Glande Sublinguale : La Plus Petite



Morphologie et Situation Spatiale :

Hiérarchie : C'est la plus petite des glandes salivaires principales.

Morphologie : En forme d'amande, pesant 2 à 3 grammes.

Repères Exactes : Sous la muqueuse de la fosse sublinguale, au-dessus du muscle mylo-hyoïdien, médialement à la mandibule, au-dessus et en avant de la glande submandibulaire.

Rapports et Vascularisation :

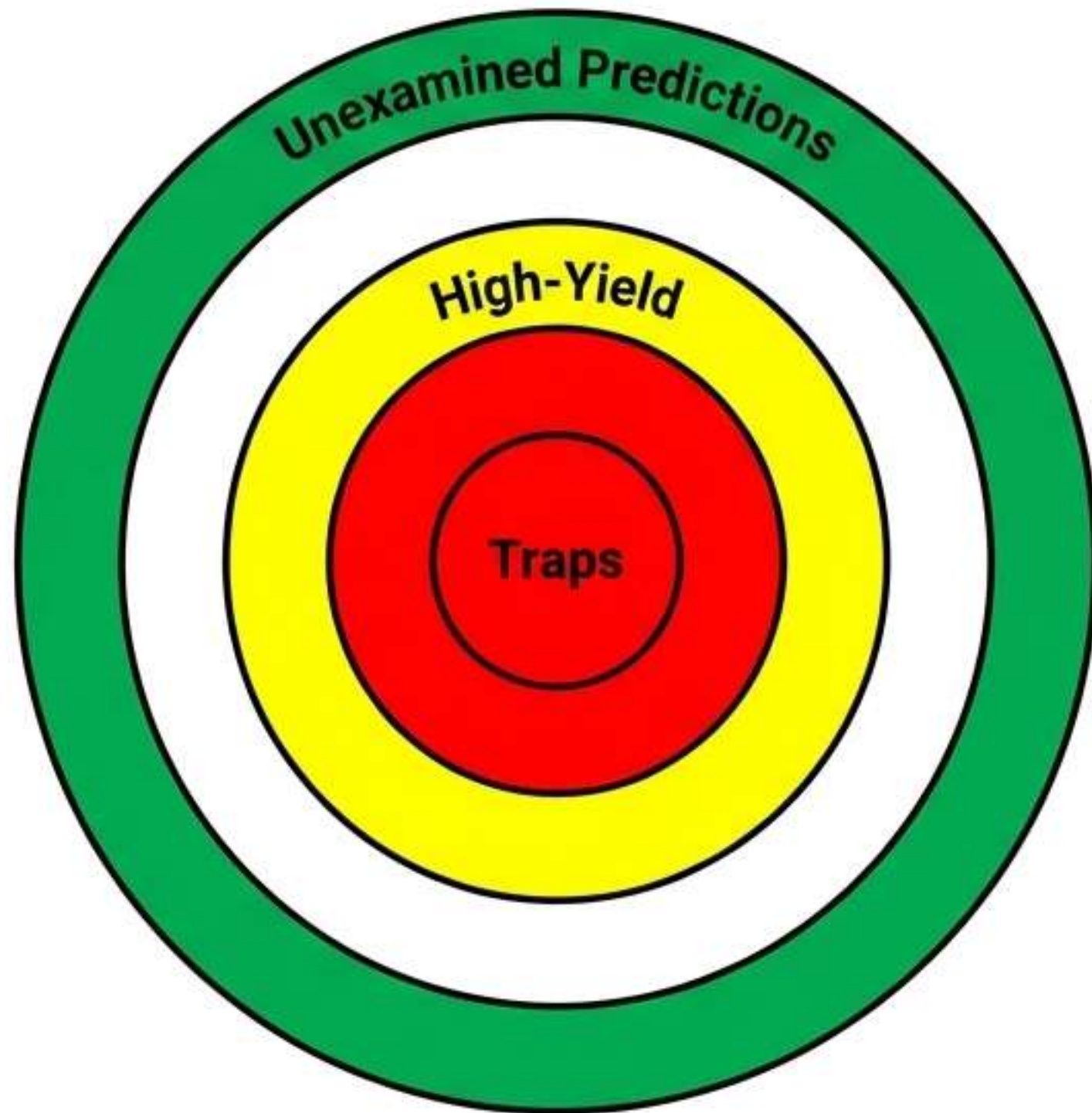
- Entre en rapport avec le nerf lingual, le canal de Wharton et le nerf hypoglosse.
- Vascularisée exclusivement par une branche de l'artère linguale.

Synthèse Comparative des Glandes Principales

PARAMÈTRE	PAROTIDE	SUBMANDIBULAIRE	SUBLINGUALE
Taille/Poids	La plus volumineuse (25g)	Intermédiaire (7g)	La plus petite (2-3g)
Conduit Excréteur	Canal de Sténon (4 cm)	Canal de Wharton	N/A (Canaux courts/multiples sous-entendus par la source)
Lieu d'Abouchement	Vestibule, collet 2ème molaire supérieure	Caroncule salivaire (frein de la langue)	Fosse sublinguale
Nerfs en Rapport	Facial (Intra), Auriculo-temporal (Intra)	Lingual, Grand hypoglosse	Lingual, Hypoglosse

Analyse des Modèles d'Examen (Exam Pattern Analysis)

[Indice de Confiance de Prédiction : 95%]



Cibles Répétées (High-Yield) :

1. **Trajet du Sténon** : Croise toujours le masséter, perfore toujours le buccinateur.
2. **Confusion des Loges (Le Piège Absolu)** : Carotide Externe + Veine Rétro-mandibulaire (INTRINSÈQUE) vs Carotide Interne + Veine Jugulaire Interne (EXTRINSÈQUE/Rétro-stylien).
3. **Abouchements** : Sténon = 2ème molaire sup. Wharton = Caroncule/Frein de la langue.

Zones à Haut Risque (Prédictions Vertes) :

1. **Chiffres Exacts** : Volumes (1.5L), Longueur (4 cm pour Sténon), Poids (25g, 7g, 2-3g).
2. **Système Végétatif** : Parotide (Auriculotemporal/Sécrétoire vs Plexus carotidien/Vasomoteur).
3. **L'Ordre du Diaphragme Stylien** : Composition stricte de dehors en dedans.

